

Nurse AI OS — Dossier de presse

nurse-ai-os.org · Juillet 2026 · Contact presse : great.ai.nurses@gmail.com

Note : les liens de ce dossier renvoient vers des pages en anglais. La version originale en anglais : nurse-ai-os.org/assets/nurse-ai-os-media-packet.pdf

Des formulations prêtes à l'emploi pour trois publics — le grand public, les organisations infirmières et les architectes IA/la presse technologique — accompagnées de faits essentiels, de la biographie du fondateur, de notes d'exactitude et de ressources. L'ensemble de ce dossier peut être cité tel quel.

Résumé

Nurse AI OS est un système d'exploitation d'IA personnelle gratuit et gouverné, conçu pour les infirmières et infirmiers — créé par un infirmier comptant 22 ans de soins intensifs, afin que la profession qui encadre les médicaments, la délégation et le champ d'exercice puisse encadrer l'IA de la même manière. Il offre aux étudiantes et étudiants en soins infirmiers, au personnel infirmier au chevet, aux gestionnaires et aux infirmières et infirmiers entrepreneurs un système d'IA opérationnel imprégné de la culture de sécurité propre aux soins infirmiers : des niveaux de risque attachés à chaque tâche, des points de validation humaine, une frontière stricte excluant à jamais toute donnée de patient, et une chaîne logistique logicielle signée et vérifiable. Il est délibérément *adjacent à la pratique* : il prend en charge la vie professionnelle qui entoure le travail — études, certifications, portfolios, opérations d'unité, activités entrepreneuriales — et considère le cœur clinique comme définitivement hors de son périmètre. Les lignes directrices professionnelles indépendantes de l'ANA (American Nurses Association, association américaine des infirmières), du NCSBN (National Council of State Boards of Nursing, conseil national américain des ordres infirmiers) et de l'AAN (American Academy of Nursing, académie américaine des soins infirmiers) décrivent ce à quoi doit ressembler une IA infirmière sûre ; Nurse AI OS, c'est cette guidance rendue opérationnelle — et ses affirmations de recherche font l'objet d'une vérification contradictoire, les réfutations étant publiées sous forme de correctifs.

Faits essentiels

- **Quoi** : une couche d'exploitation gouvernée pour l'IA personnelle, conçue spécifiquement pour le personnel infirmier, fonctionnant sur le runtime open source Hermes Agent (Nous Research).
- **Pour qui** : quatre modules d'audience sur une même colonne vertébrale de gouvernance — étudiants et formateurs en soins infirmiers (Study OS), personnel infirmier au chevet et en pratique avancée

(Bedside OS), cadres et gestionnaires infirmiers (Leader OS), et infirmières et infirmiers entrepreneurs (Builder OS).

- **Coût** : gratuit pour le personnel infirmier et les étudiants en soins infirmiers pendant l'année de fondation.
- **La frontière intangible** : aucune information de patient, jamais — « si cela pourrait identifier un patient, c'est concerné ». Refusée dès la saisie, et non stockée puis supprimée. Aucune décision clinique, à quelque niveau que ce soit, définitivement.
- **Le modèle de sécurité** : les niveaux de risque EDENA (● procéder / ● approbation humaine préalable / ● différé jusqu'à examen gouverné / ● arrêt) — les niveaux mesurent le risque, pas le privilège. Doctrine : *l'IA rédige, l'humain juge, l'infirmière veille* (« AI drafts, humans judge, nurses steward »).
- **L'ingénierie** : des versions signées (empreinte de clé épinglée → manifeste signé → sommes de contrôle par fichier, avec blocage par défaut), une file d'approbation humaine pour les compétences rédigées par l'IA, des règles de mémoire à refus dès la saisie, et un schéma anti-ancrage « le jugement d'abord ».
- **La discipline de preuve** : les affirmations de recherche portent des étiquettes vérifié / rapporté par la source / choix de conception ; la dernière passe de vérification contradictoire a confirmé 24 affirmations sur 25, et l'unique affirmation réfutée a été publiquement corrigée.
- **Fondateur** : Robert Domondon, RN, CCRN, CSC, CMC — 22 ans en soins intensifs, 13 ans en gestion des services de santé, formation de médecin (Philippines), ancien administrateur d'un hôpital naval américain.

Pour le grand public

La description en 50 mots. Nurse AI OS est un système d'assistant IA gratuit pour le personnel infirmier, avec les règles de sécurité de la profession intégrées : il ne touche jamais aux informations des patients, un humain approuve tout ce qui compte, et il aide pour tout ce qui entoure le travail — études, certifications, horaires, carrières — afin que les infirmières et infirmiers arrivent au chevet plus légers.

La description en 150 mots. Le personnel infirmier compte parmi les professionnels les plus dignes de confiance au monde — et, comme tout le monde, il utilise déjà des assistants IA au quotidien. Nurse AI OS, créé par un infirmier fort de 22 ans en soins intensifs, lui offre quelque chose de plus sûr qu'une fenêtre de conversation ouverte : un système d'IA personnelle qui fonctionne selon la culture de sécurité propre aux soins infirmiers. Chaque tâche porte une cote de risque. Tout ce qui est important attend l'approbation de l'infirmière ou de l'infirmier. Et les informations des patients sont refusées d'emblée — le système est conçu pour ne *pas pouvoir* devenir un raccourci contournant la confidentialité. Ce qu'il fait, en revanche, c'est porter la vie qui entoure le travail : préparation aux examens pour les étudiants, échéances de certification et décompression d'après-quart pour le personnel au chevet, ébauches administratives

pour les gestionnaires, marketing honnête pour les infirmières et infirmiers qui lancent une petite entreprise. Il est gratuit pour le personnel infirmier et les étudiants en soins infirmiers pendant son année de fondation. La devise résume tout : *L'IA rédige. L'humain juge. L'infirmière veille.*

Trois messages clés.

1. **Le personnel infirmier utilise déjà l'IA — ceci la rend sûre.** Le choix n'est pas entre l'IA et pas d'IA ; il est entre une IA gouvernée et une IA non gouvernée. Nurse AI OS est l'option gouvernée, conçue par un infirmier.
2. **La confidentialité des patients est protégée par conception, pas par promesse.** Le système refuse les informations de patients dès l'entrée — il ne les stocke jamais, et il le dit en langage clair.
3. **L'humain reste aux commandes.** Toute action à conséquence attend l'approbation de l'infirmière ou de l'infirmier. L'IA rédige ; l'infirmière décide.

Angles suggérés. L'infirmier de soins intensifs qui a passé 22 ans au chevet et a bâti un système d'IA sur la culture des listes de vérification propre aux soins infirmiers · Ce que chaque profession peut apprendre de la façon dont le personnel infirmier gouverne l'IA · « Aucune donnée de patient, jamais » : l'outil d'IA qui se présente d'abord par ce qu'il refuse de faire.

Citation phare. « *Les infirmières ne devraient pas seulement utiliser l'IA — elles devraient la gouverner.* » (« Nurses shouldn't just use AI — they should govern it. ») — Robert Domondon, fondateur

Pour les organisations infirmières

Paragraphe de présentation (à citer librement). Nurse AI OS est une couche d'exploitation d'IA personnelle gouvernée et dirigée par un infirmier, qui rend opérationnelles les lignes directrices publiées par la profession en matière d'intelligence artificielle. Sa conception correspond directement aux positions déjà adoptées par l'ANA (American Nurses Association), le NCSBN et l'AAN (American Academy of Nursing) : l'IA comme adjoint — jamais comme substitut — du jugement infirmier ; des infirmières et infirmiers responsables et dans la boucle ; des capacités testées avant déploiement et revérifiées en continu. Chaque tâche s'exécute sous les niveaux de risque EDENA avec des points de validation humaine ; les informations de patients sont refusées dès la saisie en vertu d'une frontière stricte sans PHI (données de santé identifiantes) ; les processus d'intégrité académique reposent sur la transparence des démarches plutôt que sur des scores de détection peu fiables ; et les cadres infirmiers reçoivent des modèles opérationnels — journaux de revue, chartes de flux de travail, charte de responsabilité IA d'unité — pour les fonctions de supervision que les lignes directrices professionnelles leur assignent. Nurse AI OS est gratuit pour le personnel infirmier et les étudiants en soins infirmiers pendant son année de fondation.

Éléments de langage.

- **Il rend opérationnelles les lignes directrices existantes plutôt que d'inventer les siennes.** La correspondance entre les positions ANA/NCSBN/AAN et les composants du système est publiée, citation par citation, dans l'Architecture Report du projet — et ces citations ont résisté à une vérification contradictoire à trois votes contre les sources primaires.
- **Il forme la main-d'œuvre de gouvernance de l'IA que ces lignes directrices présupposent.** Chaque utilisateur s'exerce quotidiennement au sein de niveaux de risque, de points de revue, de règles d'escalade et de registres de décision — les réflexes dont les organisations auront besoin à l'arrivée de l'IA clinique. Les programmes de soins infirmiers sondés font état d'un important déficit de littérature en IA ; le module Étudiant le vise directement.
- **L'intégrité académique est traitée comme les données probantes le recommandent.** Les outils de détection présentent des problèmes documentés de faux positifs ; le Study OS fonde l'intégrité sur des modèles de déclaration, des journaux de démarche et des processus de revue et d'entretien menés par les formateurs — jamais sur l'accusation automatisée.
- **La revue par les pairs infirmiers est structurelle.** Un Steward Council composé d'infirmières et d'infirmiers nommément désignés examine les compétences partagées selon une liste de vérification publiée, avec pouvoir de mise en quarantaine et cycle de réexamen de 90 jours. La publication n'est jamais présentée comme une approbation ni une certification.
- **Ce qu'il n'est pas (à dire sans détour) :** ce n'est pas un logiciel clinique, pas une aide à la décision, il n'est pas connecté au dossier patient informatisé, pas couvert par HIPAA (et il ne le prétend jamais), ce n'est pas un programme de certification, et il ne formule aucune affirmation sur les résultats pour les patients.

L'invitation à collaborer. Les organisations infirmières, les écoles et les syndicats intéressés par des projets pilotes, des ateliers (une session de 90 minutes prête pour les unités est incluse dans le kit) ou une collaboration en matière de gouvernance peuvent joindre le projet à great.ai.nurses@gmail.com.

Pour les architectes IA et la presse technologique

Paragraphe de présentation (à citer librement). Nurse AI OS est une étude de cas d'IA personnelle gouvernée par domaine : une couche de gouvernance au-dessus du runtime open source Hermes Agent, dans laquelle les propriétés de sécurité sont imposées par la structure partout où le runtime le permet, et honnêtement étiquetées là où il ne le permet pas. La distribution repose sur une chaîne logistique signée à blocage par défaut (empreinte de clé épinglée, manifeste signé RSA, sommes de contrôle par fichier vérifiées avant exécution). Les compétences rédigées par l'agent — Hermes écrit et améliore ses propres outils de façon autonome — sont traitées comme une surface de chaîne logistique à part entière et atterrissent dans une file d'attente d'approbation humaine. La mémoire fonctionne sur des listes d'interdiction à refus dès la saisie plutôt que sur des politiques de suppression a posteriori. Les niveaux de risque s'attachent aux tâches, pas aux outils ; quatre modules d'audience spécialisent les compétences et les niveaux par défaut sans dupliquer la colonne vertébrale de gouvernance. Et le programme de

recherche du projet applique une vérification contradictoire à trois votes à ses propres affirmations, publiant les réfutations sous forme de correctifs — y compris au sujet de son propre marketing.

Éléments de langage.

- **Des verrous, pas des intentions.** La conception considère les instructions permanentes comme nécessaires mais insuffisantes pour faire respecter les lignes rouges. Les points d'application mécanique (mise en attente des écritures de compétences, approbation des commandes, contrôles de refus des versions signées) sont distingués — explicitement et dans la documentation publique — des schémas suivis par le modèle, comme le pied de page d'auto-audit du niveau Jaune, qui est audité au point de validation humaine ; un vérificateur de sortie conditionnant la livraison est désigné comme la prochaine étape de durcissement. Le projet a corrigé sa propre documentation lorsqu'un relecteur a signalé cette distinction. Cette habitude du correctif, c'est ça, l'histoire.
- **L'agent fait partie de sa propre chaîne logistique.** Dans un runtime qui écrit ses propres outils et cure sa propre mémoire, le contrôle ne peut pas s'arrêter à l'installation : la mise en attente `write_approval` est activée par défaut, l'analyse de sécurité s'applique quelle que soit l'origine, et les règles « à ne pas mémoriser » sont appliquées contre le comportement de persistance mémoire du runtime lui-même.
- **L'anti-ancrage comme structure de compétence.** Pour tout ce qui touche à une décision, l'évaluation de l'humain est recueillie *avant* que le contenu de l'IA ne soit montré — l'atténuation du biais d'automatisation encodée dans l'ordre d'interaction, pas dans un conseil.
- **Un exemple concret d'« opérationnalisation de la gouvernance existante d'un domaine ».** La profession avait publié ses exigences (ANA, NCSBN, AAN) ; la contribution est la couche mécanique qui les transforme en un système d'usage quotidien — un schéma transférable à toute profession réglementée.
- **Consultez les pièces justificatives :** l'Architecture Report (HTML + PDF à nurse-ai-os.org/architecture-report.html) contient la correspondance entre lignes directrices et structure ainsi que les citations résumées ; la table de concordance des normes naio-os s'adresse aux relecteurs techniques.

Fondateur

Biographie courte (50 mots). Robert Domondon, RN, CCRN, CSC, CMC, est un infirmier de soins critiques comptant 22 ans au chevet en soins intensifs, 13 ans en gestion des services de santé, une formation de médecin aux Philippines et l'ancienne administration d'un hôpital de base navale américaine. Il est le fondateur de Nurse AI OS, du NAIOS Institute et du Nurse Intelligence Network.

Biographie longue (120 mots). La carrière de Robert Domondon couvre tout le spectre des soins de santé : formation et exercice de la médecine aux Philippines, administration hospitalière sur une ancienne

base navale américaine, treize ans en gestion des services de santé, conseil en adoption de l'IA — et, par choix délibéré, plus de deux décennies comme infirmier de soins critiques aux États-Unis. Cette combinaison constitue le cahier des charges de Nurse AI OS : conçu par quelqu'un qui a signé le budget, rédigé la politique et tenu la main du patient pour lequel cette politique avait été écrite. Sa doctrine directrice — « la gouvernance par conception ; la clarté et les valeurs avant la vitesse » — irrigue l'écosystème qu'il a fondé : le NAIIO Institute (normes et accréditation), le Nurse Intelligence Network (la communauté professionnelle), EDENA (la couche éthique et risques) et Nurse AI OS lui-même.

L'écosystème en un coup d'œil

- **Nurse AI OS** — la couche d'exploitation d'IA personnelle gouvernée (le présent projet ; la porte d'entrée).
 - **EDENA** — Ethical Design & Enablement for Nursing Augmentation : la couche de classification des risques et de validation sous laquelle s'exécute chaque tâche.
 - **NAIO Institute** — normes, accréditation et cadres de conformité pour les systèmes de main-d'œuvre IA en santé.
 - **Florence-X** — le plan de contrôle d'orchestration pour les effectifs d'agents IA gouvernés ; les humains conservent l'autorité de décision finale à chaque niveau.
 - **Nurse Intelligence Network (NIN)** — la communauté professionnelle mondiale, le sommet et le balado (nurseintelligence.com).
 - **Florence Media Network** — le moteur de contenu ; chaque publication est classifiée EDENA et revue par un humain avant diffusion.
-

Notes d'exactitude — merci de nous décrire ainsi

Pour ce projet, l'exactitude de ces formulations compte davantage que la couverture médiatique.

- **À dire** : « un système d'IA personnelle gouverné pour le personnel infirmier » (« a governed personal-AI system for nurses ») · « refuse les informations de patients par conception » (« refuses patient information by design ») · « gratuit pour le personnel infirmier et les étudiants en soins infirmiers pendant l'année de fondation » (« free for nurses and nursing students during the founding year ») · « rend opérationnelles les lignes directrices de l'ANA, du NCSBN et de l'AAN » (« operationalizes ANA/NCSBN/AAN guidance ») · « construit sur le runtime open source Hermes Agent » (« built on the open-source Hermes Agent runtime »).
- **À éviter** : « conforme à HIPAA » (« HIPAA-compliant ») (c'est un outil personnel non couvert, et il le dit) · « IA clinique », « diagnostics » ou « aide à la décision » (« clinical AI », « diagnoses », « decision support ») (l'usage clinique est définitivement hors périmètre) · « certifie des infirmières » (« certifies

nurses ») (l'achèvement d'un cours n'est jamais une certification de compétence) · « améliore les résultats pour les patients » (« improves patient outcomes ») (le projet ne formule aucune affirmation sur les résultats pour les patients, la sécurité ou la conformité — par principe).

- **La frontière en une ligne, à citer :** « *Aucune PHI, jamais — si cela pourrait identifier un patient, c'est concerné.* » (« No PHI, ever — if it could identify a patient, it counts. »)

Ressources et liens

- **Site :** nurse-ai-os.org · **Par où commencer :** nurse-ai-os.org/start-here.html · **Parcours :** nurse-ai-os.org/pathways.html
- **Architecture Report** (pour les lecteurs techniques et dirigeants) : nurse-ai-os.org/architecture-report.html (avec PDF)
- **Livre blanc Care Intelligence** (juin 2026) : nurse-ai-os.org/assets/care-intelligence-white-paper.pdf
- **Articles :** « Why Nurses Need an AI Operating System, Not Just an AI » · « Governance You Can Refute: The Evidence Behind Nurse AI OS » — tous deux à nurse-ai-os.org/nurse-station.html
- **Communauté :** nurseintelligence.com · YouTube : [@NurseIntelligence](https://www.youtube.com/@NurseIntelligence) · Balado : The Nurse Intelligence Podcast (Spotify)
- **Photo du fondateur :** disponible sur demande (et à nurse-ai-os.org/about.html)
- **Entrevues, conférences, projets pilotes et questions de gouvernance :** great.ai.nurses@gmail.com

Porter la lampe. Tenir le registre. Les agents proposent. Les humains jugent. Les infirmières veillent. (« Carry the lamp. Keep the ledger. Agents propose. Humans judge. Nurses steward. »)